MINISTERIO DE SALUD

No.653-2020/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

P. MAZZETTI

V. BOCANGEL

Resolución Ministerial

Lima, 21 de Agosto del 2020

L. SUÁREZ

Visto, el Expediente N° 19-103171-001 que contiene el Informe N° 028-2019-AKT-DGIESP/MINSA, Informe N° 031-2019-AKT-DGIESP/MINSA, y el Informe N° 008-2020-MMOA-DA-DGIESP/MINSA, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; así como el Informe N° 837-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

G. REVILLA S.

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

L. CUEVA

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, señala que el presente Decreto Legislativo determina y regula el ámbito de competencia, las funciones, la estructura orgánica básica del Ministerio de Salud y su función rectora como único ente que establece políticas en materia de salud a nivel nacional, con la finalidad de disponer la estandarización de los procesos, a fin de brindar atenciones oportunas y de calidad; así como, determina también sus relaciones de articulación y coordinación con otras entidades;

N. HUAMANÍ

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del precitado Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades, disponen que son funciones rectoras del Ministerio de Salud el formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como, el dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud;

S. YANCOURT

Que, el literal b) del artículo 64 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado con Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene como una de sus funciones, proponer, evaluar y supervisar la implementación de políticas, normas, lineamientos y otros documentos normativos en materia de intervenciones estratégicas de Salud Pública;

V. BOCANGEL

Que, mediante los informes del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, en el marco de sus competencias y funciones, ha propuesto el Documento Técnico: Bases conceptuales para el ejercicio de la rectoría sectorial del Ministerio de Salud, con la finalidad de facilitar y contribuir al fortalecimiento del ejercicio de la rectoría sectorial del Ministerio de Salud y de la función de regulación correspondiente;

L. SUÁREZ

Que, ante lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo que apruebe el Documento Técnico: Bases Conceptuales para el ejercicio de la rectoría sectorial del Ministerio de Salud;

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, del Director General de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaria General, del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y del Viceministro de Salud Pública; y,

L. CUEVA

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, y el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades; así como el Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

N. HUAMANÍ

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: Bases Conceptuales para el ejercicio de la rectoría sectorial del Ministerio de Salud, que en documento adjunto forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

G. REVILLA S.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y el documento adjunto que forma parte del mismo, en el portal institucional del Ministerio de Salud.

S. YANCOURT

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER

Ministra de Salud

DOCUMENTO TÉCNICO

"BASES CONCEPTUALES PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA SECTORIAL DEL MINISTERIO DE SALUD"

I. FINALIDAD

Facilitar y contribuir al fortalecimiento del ejercicio de la rectoría sectorial del Ministerio de Salud y de la función de regulación correspondiente.

II. OBJETIVOS

- Fortalecer la función de regulación del nivel nacional en la formulación de documentos normativos en salud, como parte del ejercicio de la rectoría sectorial del Ministerio de Salud.
- Establecer las definiciones y conceptos utilizados con más frecuencia en la formulación de proyectos de documentos legales y normativos del Ministerio de Salud.
- Mejorar las competencias de los equipos técnicos y de los funcionarios del Ministerio de Salud que participan en la función de regulación.

III. BASE LEGAL

- ✓ Ley N. ° 26842, Ley General de Salud
- ✓ Ley N. ° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- ✓ Ley N. ° 30895, Ley que Fortalece la Función Rectora del Ministerio de Salud
- ✓ Decreto Legislativo N. ° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud
- ✓ Decreto Legislativo N. ° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades
- ✓ Decreto Supremo N. ° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y modificatorias

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento técnico es de consulta y referencia obligatoria para el Ministerio de Salud, sus órganos, organismos públicos adscritos y órganos desconcentrados, en el desarrollo de sus actividades relacionadas con la formulación de proyectos de normas con rango de ley, normas reglamentarias, y demás documentos normativos.

Este documento debe servir de orientación para los demás subsectores: EsSalud y sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (bajo el ámbito de los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, Defensa e Interior, respectivamente), y niveles de gobierno (gobiernos regionales y locales) a fin de contribuir a armonizar y fortalecer el ejercicio de la Rectoría del Sector Salud del Ministerio de Salud y de la función de regulación.

MINISTERIO DE SALUD DG N. HUAMANI

V. CONSIDERACIONES GENERALES

5.1. El presente documento técnico es de consulta y referencia obligatoria para funcionarios, servidores, personal y equipos técnicos del MINSA, que participan en la elaboración de proyectos de normas legales, reglamentarias y documentos normativos de la entidad.

5.2. Las definiciones y conceptos del presente documento técnico, cuando corresponda, son utilizados en la formulación de normas, leyes, reglamentos, planes y otros, para contribuir a armonizar y fortalecer su desarrollo.

5.3. Las definiciones y conceptos que se incluyen toman en cuenta aquellos casos en los que puede haber más de una acepción, y que cada una de ellas tiene un significado particular y diferente, haciéndose la precisión de cuál es la que se debe usar y en qué circunstancias, según corresponda.

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Las siguientes definiciones y conceptos serán utilizadas en la formulación de proyectos de normas legales, reglamentarias y documentos normativos del Ministerio de Salud.

1) ACTO DE SALUD. -

Es toda acción o actividad que realizan los profesionales de la salud, excepto el médico cirujano, para las intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, según corresponda; que se brindan a la persona, familia y comunidad. La recuperación incluye la evaluación clínica, diagnóstico, pronóstico, terapéutica y seguimiento, según las competencias de cada profesional de la salud, de acuerdo a Ley.

2) ACTO MÉDICO. -

Es toda acción o disposición que realiza el médico cirujano en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación que realiza el médico en la atención integral de personas, familia y comunidad, así como los que se deriven directamente de éstos.

3) ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD. -

Ver concepto de *Cobertura Universal en Salud*

4) ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD. -

Es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)

5) ASISTENCIA TÉCNICA. –

Es el proceso planificado, permanente e interactivo mediante el cual se fortalecen los conocimientos, habilidades y destrezas de una unidad de organización que requiere de ella, por parte de otra unidad de organización con experiencia técnica y competencias funcionales para hacerlo.

N. HUAMANÍ

6) ATENCIÓN DE SALUD. -

Se denomina así a cada uno de los servicios que recibe o solicita un usuario de los servicios de salud. Pueden ser de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, según corresponda; y pueden brindarse dentro del establecimiento de salud (atenciones intramurales) o en la comunidad (atenciones extramurales).

7) ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD. -

Es el conjunto de intervenciones sanitarias en los ámbitos personal, familiar y comunitario, enfocadas en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, teniendo en cuenta los aspectos físico, mental y social; provistas de manera conjunta y continua por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en términos de calidad, equidad y oportunidad; de acuerdo a su nivel resolutivo y la capacidad de oferta de los servicios de salud que brindan.

8) ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD. -

Es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, así como del desarrollo social y económico global de la comunidad.

La APS se desarrolla en los 3 niveles de atención del Sistema de Salud, y no debe confundirse con el Primer Nivel de Atención.

9) CAPACIDAD DE OFERTA DE LA IPRESS. -

Es la capacidad que tiene una IPRESS para producir el número máximo de atenciones y por tipo de servicios que ofrece para atender el volumen de necesidades existentes en la población, a partir de la disponibilidad efectiva de recursos que dispone cotidianamente. Esa cantidad de atenciones debe cumplir con los estándares de calidad de referencia nacional o internacional.

10) CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA IPRESS. -

Alude a la capacidad efectiva de una o un conjunto de IPRESS para satisfacer las necesidades y demandas de atención de salud de la población de su ámbito o jurisdicción, y resolver oportuna e integralmente los daños o patologías que la afecta. La capacidad resolutiva es una función de la disponibilidad y operatividad de los recursos con los que cuenta la o las IPRESS, y de las atenciones que oferta o servicios que produce.

11) CARPETA FAMILIAR. -

Es aquella que contiene datos referentes a una familia en su conjunto y a la vivienda en la que ésta reside. En esta carpeta se archivan la ficha familiar y las historias clínicas individuales de todos los miembros de dicha familia. La carpeta familiar se conserva y custodia en el archivo de historias clínicas del establecimiento de salud.

MINISTERIO DE SALUD
N. HUAMANÍ

12) CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD. -

Es el conjunto de servicios que produce una IPRESS, y por extensión una red de salud. Debe responder a las necesidades de salud de la población y las prioridades sanitarias establecidas por la ANS. No se refiere a los servicios como unidades orgánicas de las IPRESS.

13) CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y SANITARIOS (CPMS). -

Es la relación ordenada de los Procedimientos Médicos y Sanitarios que se brindan en una IPRESS, o una red de salud, y que incluye sus denominaciones correctas y los respectivos códigos de identificación estándar en salud

14) CICLO DE VIDA. -

Ciclo de vida de la persona es el proceso vital que se desarrolla en ella a partir de la reproducción, siguiendo por su nacimiento hasta su muerte. Ese ciclo se cumple a través de diversas etapas.

15) CLIENTE. -

Es el usuario de los servicios de salud de una IPRESS, desde la perspectiva de la Gerencia o Gestión en Salud o Gestión de la Calidad en Salud; independiente de relacionarse o condicionarse al pago de la atención recibida o a la percepción de utilidades por el proveedor público o privado.

El cliente tiene una necesidad individual y personal, que debe ser satisfecha con el servicio (o bien) que el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo produce.

16) COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD. -

La cobertura universal de salud y el acceso universal a la salud implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios de salud integrales, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras o empobrecimiento, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad. Se basa en reconocer que la salud es un derecho humano fundamental, y la equidad es un aspecto primordial para hacerlo efectivo.

17) COMPLEMENTARIEDAD DE SERVICIOS DE SALUD. -

Característica de la Red de Salud o del Sistema de Salud de poder satisfacer las necesidades de atención de la población a su cargo, a partir de la coordinación de los procesos, recursos (humanos, equipamiento, servicios, etc.) y capacidad resolutiva de las diversas IPRESS, de tal manera que responden con eficiencia y oportunidad a la demanda local.

18) CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE SALUD. -

Característica del Sistema de Salud de poder asegurar que los pacientes puedan ser atendidos de acuerdo al nivel de complejidad que requieran según la patología que les afecte, en las IPRESS de los diferentes niveles de atención, sin interrumpir la atención o tratamiento. Esto implica tener un operativo, adecuado y oportuno flujo de referencia y contra referencia.

MINISTERIO DE SALUD
DG
N. HUAMANÍ

19) CUIDADO DE LA SALUD. -

Acción de proteger, cautelar, preservar, de manera empática, el Derecho a la Salud de los individuos, el entorno familiar y la comunidad en la que vive; estas acciones, pueden ser realizadas por las personas, las organizaciones, la sociedad o el Estado.

20) CUIDADOS INTEGRALES DE LA SALUD. -

Son las acciones e intervenciones personales, familiares y comunitaria destinadas a promover hábitos y conductas saludables; buscan preservar la salud, recuperarla de alguna dolencia o enfermedad, rehabilitarla, paliar el sufrimiento físico o mental, fortalecer la protección familiar y social.

Comprende, por un lado, las intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud en torno a la persona, familia y comunidad, en el Sistema de Salud, considerando las dimensiones bio psico sociales de los individuos, aplicando los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y equidad en salud.

Además, comprende las intervenciones intersectoriales e intergubernamentales sobre las Determinantes Sociales de la Salud, bajo la Rectoría del Ministerio de Salud, abordando el marco socio económico político cultural, las determinantes estructurales y las determinantes intermedios, incluido el Sistema de Salud, con la finalidad de construir un país y una sociedad saludables.

21) CUIDADOS INTEGRALES DE LA SALUD, MODELO DE. -

Es el conjunto de conceptos, principios, lineamientos e intervenciones, que permiten el desarrollo de los cuidados integrales de salud, mediante la participación del Estado, la sociedad, las organizaciones, las personas y sus familias, cuya finalidad es garantizar el Derecho a la Salud, asumiendo roles y responsabilidades para proteger, cautelar, y preservar dicho derecho.

22) CUIDADOS PALIATIVOS. -

Es la atención que se ofrece a pacientes y familias, que sufren alguna enfermedad severa, generalmente crónica, progresiva, incurable e intratable, que limita o acorta la vida, y que se acompaña de una serie de síntomas y signos que requieren tratamiento. Como parte de la atención integral de salud, está comprendida dentro de la intervención sanitaria de recuperación en salud.

Los Cuidados Paliativos (CP) procuran:

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal;
- Prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicológico, social o espiritual.

Los CP reafirman el valor de la vida, y reconocen que la muerte es parte del proceso normal de todo ser humano, y en este sentido, brindan el acompañamiento necesario, sin pretender acelerarla o retardarla, evitando el sufrimiento innecesario y respetando la dignidad de la persona hasta el desenlace final. Los cuidados paliativos no terminan con la muerte de la persona, sino que continúa con el soporte del duelo a la familia.

MINISTERIO DE SALUD
DG
N. HUAMANÍ

23) CURSO DE VIDA, ENFOQUE DE. -

Es el enfoque que considera la forma en que la salud de un individuo, su comunidad, su entorno y otros factores, así como la salud de las generaciones anteriores y futuras están interconectadas a lo largo de la vida.

Considera a la salud como un proceso dinámico que requiere ir más allá de las intervenciones dirigidas a enfermedades específicas. Además, entiende que la salud es un recurso esencial para la producción y el mantenimiento de capacidades en individuos y poblaciones. Así la salud es asumida como una dimensión importante y necesaria del desarrollo humano y no simplemente como un fin en sí mismo.

24) DATOS PERSONALES. -

Es toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Asimismo, es toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales o de cualquier otro tipo de una persona natural que la identifica o la hace identificable individualmente a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.

Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco

25) DATOS PERSONALES RELACIONADOS CON LA SALUD. -

Son todos aquellos referidos a la situación de salud o enfermedad de una persona, y que la identifica o la hace identificable individualmente; dicha información incluye la salud y enfermedad pasada, presente o pronosticada, física o mental, de una persona, inclusive el grado de discapacidad y su información genética

Los Datos Personales en Salud (DPS) según la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, es información confidencial que constituye datos sensibles. El acceso a esta información requiere de la autorización expresa y por escrito del titular de la información.

26) DATOS SENSIBLES. -

Son los datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.

Asimismo, es aquella información relativa a datos personales referidos a las características físicas, morales o emocionales, hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar, los hábitos personales que corresponden a la esfera más íntima, la información relativa a la salud física o mental u otras análogas que afecten su intimidad.

Para el tratamiento de datos sensibles, el consentimiento del titular de los datos debe efectuarse por escrito, salvo las excepciones previstas en la Ley Ni 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

MINISTERIO DE SALUD
DG
N. HUAMANÍ

27) DERECHO A LA SALUD. -

El Derecho a la salud, reconocido por la Constitución Política del Perú y los convenios internacionales ratificados por el Estado Peruano, así como por sentencia del Tribunal Constitucional que establece el derecho a la salud como un derecho fundamental de la persona sin distinción alguna, y corresponde al Estado y sus instituciones garantizarlo, respetarlo, promoverlo y protegerlo. No se limita únicamente al acceso a los servicios de salud.

El derecho a la salud es más que el derecho al acceso a la atención de salud, y requiere la concreción de otros derechos como el acceso a alimentación en condiciones de inocuidad y seguridad, a agua potable y saneamiento básico, al fomento de ambientes saludables en la familia, el trabajo y la comunidad, y al acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, aplicando los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.

28) DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. -

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas son concebidas, nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, y son causa de buena parte de las inequidades en salud entre los países y dentro de cada país.

El término «determinantes sociales» resume el conjunto de factores sociales, políticos, económicos, biológicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud de la población y sus diferencias entre un país y otro, e incluso dentro de un mismo país. Comprende a los determinantes estructurales y a los determinantes intermedios, y a las condiciones de vida que ellos generan en la población.

Resultan de la distribución del poder, los ingresos y los bienes y servicios; las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a la atención sanitaria, la escolarización y la educación; sus condiciones de trabajo y ocio; y el estado de su vivienda y entorno físico.

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades en salud, esto es, de las diferencias evitables e injustas observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria.

El **contexto socio económico y político** incluye el ejercicio de la gobernanza, el modelo de desarrollo predominante, las políticas macroeconómicas, sociales y sanitarias, que estructuran los mecanismos sociales y políticos que generan, configuran y mantienen las diferencias sociales, como: el mercado laboral, el sistema educativo, las instituciones políticas y otros valores culturales y sociales.

Los **determinantes estructurales** incluyen a los **estratificadores estructurales** que generan la gradiente social: ingresos, nivel educativo, ocupación, clase social, género, raza / etnia.

Los **determinantes intermedios** incluyen a las condiciones materiales en las que se vive; las circunstancias psicosociales; los comportamientos o estilos de vida, los factores biológicos; y el propio sistema de salud como un determinante social.

MINISTERIO DE SALUD
DG
N. HUAMANÍ

29) DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, ABORDAJE DE LOS. -

Implica la decisión de superar las inequidades en salud actuando sobre los determinantes sociales de la salud (DSS). Esto requiere la comprensión de que:

a) La mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los países y las grandes inequidades en salud en los países están provocadas por una distribución desigual del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible (acceso a atención sanitaria, escolarización, educación, condiciones de trabajo y tiempo libre, vivienda, comunidades, pueblos o ciudades) y a la posibilidad de tener una vida saludable y próspera.

b) El Sistema de Salud, al ser uno de los determinantes intermedios, no es suficiente para resolver las inequidades en salud.

El abordaje de los DSS pasa por dejar de tener un enfoque medicalizado del proceso salud enfermedad, y entender que las posibilidades de la población de enfermar, acceder a la atención y de curarse, dependen de la acción sobre los determinantes estructurales, y definir políticas públicas de salud que los modifiquen.

Las acciones sobre los determinantes estructurales demandan mayor capacidad de intervención, toman más tiempo en mostrar resultados, pero sus posibilidades de impacto son mayores. Las acciones sobre los determinantes intermedios pueden obtener resultados a corto o mediano plazo, pero su sostenibilidad en el tiempo es poco probable.

La acción sobre los DSS es un reto del Estado para un trabajo multisectorial, pero corresponde a la Autoridad Nacional de Salud en el ejercicio de la Rectoría en Salud, incluirlo en la agenda política y liderar las acciones a desarrollar.

30) ENFERMO. -

Persona que está afectada por una enfermedad, independientemente de que esta última esté diagnosticada.

31) ENFOQUE. -

Dentro de la regulación en salud, constituye una perspectiva que es determinada por el ente rector competente para dirigir, encaminar y orientar el análisis, la interpretación, la elaboración y la implementación de una política pública o normatividad, con el fin de tratar de resolver acertadamente un problema público en materia de salud.

32) EQUIDAD EN SALUD. -

Es la condición ideal en la población en la que todos tienen la oportunidad de acceder al cuidado de su salud y a las atenciones de salud, en el momento que lo requiera, sin que sea alterada por razones evitables y por tanto injustas. En términos prácticos, es darle la oportunidad de acceder al cuidado y la atención de su salud, a quien no la ha tenido. La equidad en salud implica que los recursos sean asignados según la necesidad. No es darles a todos lo mismo.

Lo contrario es la ***inequidad en salud***.



33) ESTABLECIMIENTO DE SALUD. –

Son las IPRESS que realizan, en régimen ambulatorio o de internamiento, atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o restablecer el estado de salud de las personas.

34) ETAPA DE VIDA. -

Se denomina así a los varios estadios de desarrollo que atraviesa la persona a lo largo del ciclo vital natural, desde antes del nacimiento hasta la muerte.

En cada una de ellas se producen cambios físicos, emocionales, intelectuales, sicológicos, y otros atributos diferentes en cada persona, y que pueden variar de una persona a otra según su origen social, biológico o cultural, que hacen que cada persona sea diferente a las demás.

Por esto no se puede decir con exactitud cuándo inicia o culmina una etapa de vida en el desarrollo del ser humano; sin embargo, por convencionalismo, se suele establecer como referencia la edad para definir el inicio o el fin de cada una de ellas

35) EVALUACIÓN. –

Es uno de los procesos de la función de control gerencial destinado a la valoración sistemática, basada en evidencias, del logro de los objetivos de una política, programa o proyecto en curso o concluido, desde su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. Su propósito es determinar la pertinencia de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo a través del adecuado proceso de toma de decisiones.

36) FISCALIZACIÓN. –

Conjunto de acciones y diligencias de control que incluye la investigación, inspección, evaluación, supervisión y monitoreo sobre recursos, bienes y servicios de salud, a efecto de garantizar el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones establecidas por la normatividad vigente en materia de salud, bajo un enfoque de prevención de riesgos, gestión de riesgo, cumplimiento normativo y tutela del derecho a la salud.

37) GESTIÓN SANITARIA. -

Conjunto de conceptos, principios, lineamientos y acciones vinculados a la gestión de organizaciones de salud, necesarios para generar la toma de decisiones acertadas con visión estratégica, con el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de salud de la población de su influencia, promoviendo la mejora en la entrega de servicios de salud con calidad a sus usuarios. Incluye planificar, organizar dirigir y controlar en el ámbito de salud.

Se realiza a tres niveles: macrogestión (política sanitaria de un territorio), mesogestión (en los establecimientos de salud) y microgestión o gestión clínica (la gestión de los profesionales de la salud en los servicios de los niveles operativos)

38) GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD. -

Es un modelo de gestión que la autoridad del territorio del nivel local, regional o nacional implementa con el objetivo de desarrollar condiciones favorables en salud para la población de su ámbito, a través de acciones coordinadas y

MINISTERIO DE SALUD
DG
N. HUAMANÍ

articuladas para el abordaje de los determinantes sociales de la salud, garantizando la atención integral de salud en las IPRESS de su jurisdicción.

La gestión territorial en salud (GTS) implica que la Autoridad del territorio planifica, organiza, dirige y controla las acciones que involucra a las entidades del ámbito público, las organizaciones privadas y las personas, concertando con ellas para impulsar el acceso equitativo a la salud y al desarrollo de entornos saludables, en concordancia con las prioridades y políticas públicas establecidas por el Ministerio de Salud, como rector del Sector Salud.

La Red de Salud o IPRESS fomenta, promueve y contribuye a que la Autoridad local y Regional desarrollen la GTS.

39) HIGIENE DE ALIMENTOS. -

Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria.

40) IAFAS Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud. -

Son aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, que reciban, capten y/o gestionen fondos para la cobertura de las atenciones de salud o que oferten cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad.

El registro en la Superintendencia Nacional de Salud es requisito indispensable para la oferta de las coberturas antes señaladas.

41) IGUALDAD EN SALUD. -

Es la condición en la que toda la población recibe las mismas alternativas para acceder al cuidado y la atención de la salud. Esta condición admite como única diferencia el riesgo de enfermar por razones biológicas. Así, hay patologías que son propias de las mujeres y otras que solo afectan a varones; esto constituye una ***desigualdad en salud***.

El problema con esta situación es que en la población hay quienes tienen más recursos para poder ejercer su derecho a la salud, y otros que tienen menos o muy escasos recursos, generando brechas que constituyen inequidades en salud (no desigualdades en salud); si en este escenario, se les da a todos lo mismo, las brechas se mantendrán y no se habrá resuelto las condiciones de exclusión.

42) INEQUIDAD EN SALUD. -

La inequidad en salud está referida a las diferencias que existen entre las personas para ejercer su derecho a la salud, por causas que no responden a causas biológicas, y por tanto son injustas y evitables. Esas diferencias suelen obedecer a razones de estratificación social, económica, geográfica, étnica, de género, entre otras.

43) INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. -

La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.

Corresponde al Ministerio de Salud, como ente rector, establecer los estándares de límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas y fármacos de uso veterinario, contaminantes químicos, físicos y microbiológicos para

MINISTERIO DE SALUD DG N. HUAMAN

alimentos destinados al consumo humano. Así mismo en materia de los alimentos elaborados industrialmente a excepción de los pesqueros y acuícolas; y en servicios de alimentación colectiva.

44) INTERCAMBIO PRESTACIONAL. -

Entiéndase por intercambio prestacional a las acciones de articulación interinstitucional que garantice el otorgamiento y financiamiento de las prestaciones de salud centradas en el ciudadano, entre Instituciones Administradoras de Fondos del Aseguramiento en Salud (IAFAS), Unidades de Gestión de las IPRESS (UGIPRESS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, generando una mayor cobertura y utilizando en forma eficiente la oferta pública disponible a nivel nacional.

45) INTERVENCIONES SANITARIAS. -

Son aquellas acciones del ámbito de la Salud Pública, que en conjunto permiten brindar atención integral en las IPRESS. Las intervenciones sanitarias son cuatro: prevención de enfermedades, promoción de la salud, recuperación de la salud y rehabilitación de la salud.

Prevención de Enfermedades

Acciones que tiene como objetivo evitar que las personas se enfermen, o que en caso de enfermar se presente un cuadro clínico menos grave y con menos complicaciones. Es importante reconocer que la realización de la prevención de las enfermedades depende principalmente del involucramiento de las personas.

Promoción de la Salud

Como intervención sanitaria, es el conjunto de acciones que tiene como objetivo trasmitir información para que las personas puedan incorporar conocimiento y desarrollar prácticas y estilos de vida saludables.

Recuperación de la Salud

Conjunto de acciones orientadas a restablecer la salud, que incluyen la evaluación clínica, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento, de la persona afectada por un daño o enfermedad. En el ciclo natural de una enfermedad, las personas afectadas pueden sanarse, mejorar, quedar con limitaciones, y en algunos casos, inevitablemente morir. Por ello, dentro de esta intervención sanitaria, la recuperación de la salud incluye los cuidados paliativos.

Rehabilitación de la Salud

Es el conjunto de acciones destinadas a lograr que las personas afectadas por alguna enfermedad puedan recuperar las capacidades que tenían antes de enfermar, hasta el nivel más óptimo, de manera que puedan reinsertarse en el menor tiempo posible a sus actividades habituales y productivas. El objetivo es evitar, idealmente, situaciones incapacitantes, temporales y permanentes.

46) IPRESS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. -

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) son aquellos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que

MINISTERIO DE SALUD
DG
N. HUAMANÍ

tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de la salud.

En adición al cumplimiento de las normas de carácter general del Ministerio de Salud, para brindar servicios de salud deberán encontrarse registradas en la Superintendencia Nacional de Salud.

47) IPRESS Consultante. -

Institución Prestadora de Servicios de Salud ubicada principalmente en un área geográfica con limitaciones de acceso o capacidad resolutiva, y que cuenta con tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), a fin de acceder a servicios de telemedicina de una o más IPRESS consultoras.

48) IPRESS Consultora. -

Institución Prestadora de Servicios de Salud registrada con el servicio de Telesalud en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – RENIPRESS, que cuenta con tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y brinda servicios de Telemedicina a las IPRESS consultantes.

49) MONITOREO. –

Es uno de los procesos de la función de control gerencial destinado a verificar el cumplimiento de las actividades programadas, en el marco del cumplimiento de las políticas, planes, programas y metas de salud

50) PACIENTE. -

Persona que por su condición, enfermedad o molestia que lo aqueja necesita recibir atención de salud en una IPRESS y es atendida.

51) PRESTACIONES DE SALUD. -

Se reconocen 2 acepciones:

1. Se usa como sinónimo de atenciones de salud.
2. Dentro de la Teoría de Seguros, se denomina así a las atenciones de salud que recibe un usuario o paciente de una IPRESS, en el contexto de una relación creada mediante un seguro de salud (público o privado). Así, todas las prestaciones son atenciones, pero no todas las atenciones son prestaciones.

52) PRINCIPIO. -

Dentro de la regulación en salud, es una base, razón fundamental, directriz o enunciado que ordena que algo sea realizado en la mayor medida posible, cumpliendo además una función interpretativa, integrativa, orientativa y limitativa y permitiendo su ponderación en casos de conflicto normativo e interpretación.

- Función interpretativa que ayuda a resolver en un sentido antes que en otro las dudas que puedan existir sobre el significado de una determinada disposición;
- Función integrativa que proporciona un criterio en ausencia de normas; es decir, en caso de vacíos;

MINISTERIO DE SALUD
DG
N. HUAMANÍ

- Función directiva, que orienta la actividad del legislador o de otros operadores a la hora de adoptar una decisión o de dotar de contenido una norma; y,
- Función limitativa, que establece las fronteras competenciales de un determinado órgano que cercena el ámbito de eficacia de una cierta regulación.

53) PROMOCIÓN DE LA SALUD. -

Se reconocen 2 acepciones:

1. Promoción de la Salud como una de las Funciones Esenciales de la Salud, se define inicialmente como el proceso de capacitar o empoderar a la población para que aumente el control sobre su propia salud y la mejore. Para mejorar la salud es necesario contar con condiciones de paz social, acceso a educación, vivienda digna, alimentación segura, mejores ingresos, ecosistema estable, justicia social y equidad en salud. Todas estas condiciones están identificadas actualmente como Determinantes Sociales de la Salud, y por tanto se entiende Promoción de la Salud como la acción mediante el abordaje de los DSS, correspondiendo esto a los niveles de gobierno nacional, regional y local. Visto así, es el Estado el que asume la acción para crear Equidad en Salud en la población, y lo debe hacer a través de la Autoridad Nacional de Salud, en el ejercicio de la Rectoría en Salud.

   Las acciones de Promoción de la Salud, desde la Autoridad Nacional y Regional de Salud deben orientarse a intervenir en los Determinantes Estructurales, en sus respectivos ámbitos, mediante el diseño e implementación de políticas públicas, a fin de obtener resultados trascendentes y permanentes. Estas acciones deben involucrar a los gobiernos locales. Las acciones sobre los Determinantes Intermedios deben ser principalmente abordadas desde el Sistema de Salud y en cada Establecimiento de Salud donde se debe brindar Atención Integral que incluya la Promoción de la Salud (en tanto intervención sanitaria).

2. Promoción de la Salud como intervención sanitaria y que se brinda dentro de la Atención Integral de Salud (Ver definición de *Intervenciones Sanitarias*).

54) RECTORÍA EN SALUD. -

Entiéndase por Rectoría en Salud a la función ineludible e indelegable del Estado, como responsable de promover, proteger y respetar la salud, la vida y el bienestar de la población, así como conducir el Sector Salud. La Rectoría en Salud implica proteger la salud como derecho humano y bien público.

La ejerce exclusivamente la Autoridad Nacional de Salud, es decir el Ministerio de Salud. Ninguna otra entidad o autoridad, organismo descentralizado, órgano desconcentrado, órgano o unidad orgánica, puede atribuirse el ejercicio de la Rectoría en materia de Salud.

55) SALUD INTERCULTURAL. -

Es el proceso de articulación de diferentes enfoques conceptuales de la atención de la salud existentes en un espacio físico o social, de una manera horizontal y respetuosa entre ellos, basada en el intercambio y discusión de ideas, prácticas y experiencias. Tiene por objeto crear estrategias de atención conjunta para abordar la salud y la enfermedad, basadas en el derecho a la vida y la salud.

N. HUAMANÍ

Implica reducir las barreras culturales existentes para la atención de la salud en:

- La forma en que el sistema oficial de atención de salud y la población conciben la vida, la salud y la enfermedad, los tratamientos y formas de prevención, entre otros.
- El acceso a la salud debido a normas y valores culturales de la población.
- Las formas de entender la atención médica, los roles de los actores involucrados.
- La manera de comunicar síntomas, o aceptar tratamientos, entre otros.
- Diferencias en el idioma y el conocimiento.

56) SALUD, INTERCULTURALIDAD EN.-

Interculturalidad en Salud es la relación de respeto que se establece entre las personas de diversos contextos culturales y étnicos, respecto a la manera que cada uno tiene para entender el proceso de salud – enfermedad, considerando sus conocimientos, creencias, interpretaciones y prácticas, así como sus formas de fundamentarlas.

En ningún caso implica privar a dichas poblaciones del derecho a acceder a la información y al conocimiento del desarrollo científico actual, así como a beneficiarse de dicha práctica, en especial si se trata de recuperar la salud o de salvar la vida. A la vez implica asegurar que tal relación intercultural se establezca sin discriminación, así como sin establecer relaciones de poder o de coerción, de ninguna de las partes. La interculturalidad en salud se basa para las partes en entender, respetar, explicar, consensuar y actuar; nunca en imponer.

La interculturalidad en salud debe ser tomada en cuenta en la formulación de políticas públicas y normatividad en salud.

57) SALUD PÚBLICA. -

Se reconocen dos acepciones:

1. La Salud Pública es un campo de acción que afecta el estado de salud en un determinado territorio (casi siempre un país o una región) en el que se desarrolla la vida de las personas, su familia, la comunidad / sociedad, y el medio ambiente correspondiente.

   Dicho campo de acción lo constituye la praxis social, la aplicación de la tecnología científicamente probada, las políticas públicas y las acciones del Estado, así como el desempeño de diversas organizaciones públicas y privadas, y de las propias personas.

   Es el resultado del accionar de factores determinantes y de las políticas públicas vigentes que responden al marco socio económico y político, las que a su vez son reflejo del accionar (o inacción) del Estado y del modelo de desarrollo imperante; así como de los factores que influyen, positiva o negativamente, para alcanzar el goce de la Salud (no solo cuando hay enfermedad); reflejando la mayor o menor posibilidad a vivir con salud de esa población a lo largo del curso de vida, y de incluso llegar a tener mayor capacidad productiva, expectativa de vida y longevidad creativa.



Se expresa en el nivel alcanzado de Equidad en Salud, que depende de las mayores o menores posibilidades y condiciones que tienen las personas y sus familias, de vivir con salud, de vivir saludablemente o, por el contrario, de vivir privado de ella y en condiciones de vulnerabilidad originada por su posición social. Por tanto, no se limita al grado de acceso a un sistema de salud, pues este no es capaz de modificar la inequidad existente.

La Salud Pública es "pública" porque concierne a todos, es de interés de todos, y no se puede enajenar o apropiar individualmente. No es correcto asumir que es "pública" porque "pertenezca" al Estado; sin embargo, corresponde al Estado ser el primer responsable de ella, como parte importante del rol del Estado de crear el bien común. Dentro del Estado corresponde a la Autoridad Nacional de Salud asumir dicha responsabilidad. Pero hay otros actores institucionales, privados, y personas individuales, quienes también son responsables de la Salud Pública, en lo que les corresponda.

Se suele confundir "*establecimientos de salud pública*" para referirse a los establecimientos de salud que son del Estado, sean del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales, en especial. Estos son "*establecimientos de salud públicos*", y no de Salud Pública.

2. Salud Pública es el cuerpo conceptual amplio y extenso, que se basa inicialmente en la Medicina, para luego haberse enriquecido de las ciencias naturales, sociales y económicas. Su objeto de estudio es la Vida y la Salud de la población, y de los factores que le influyen, dañándola o protegiéndola. Esta Salud Pública es del ámbito del mundo académico, que la estudia, analiza, sistematiza, propone intervenciones y estrategias, y concluye, para que la Autoridad de Salud pueda decidir Políticas Públicas de Salud, basadas en evidencias.

58) SECTOR SALUD. -

El Sector Salud, está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en Ley, y que tiene impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva.

Es el espacio social de confluencia de personas, organizaciones y entidades, que realizan actividades (todas o algunas de estas) relacionadas directamente con la salud individual o colectiva en el país, o que repercuten indirectamente en ella.

No establecen necesariamente entre ellas relaciones de dependencia orgánica, funcional o jurídica, sino de coincidencia de acciones, y para las cuales el marco legal vigente les define una instancia rectora: el Ministerio de Salud.

El Sector Salud está integrado por:

a) El Ministerio de Salud, que lo conduce,

b) Los Prestadores de Servicios de Salud, públicos, privados y mixtos

c) Los Compradores o Financiadores Institucionales de Servicios de Salud, públicos, privados y mixtos

d) Las Entidades formadoras de Recursos Humanos en Salud, públicos, privados y mixtos

MINISTERIO DE SALUD
DG
N. HUAMANI

e) Las Entidades productoras o comercializadoras de otros recursos en salud

f) Las Entidades que pertenecen al Estado con actividades de impacto sobre la salud o sus factores determinantes

g) Las Entidades Privadas o mixtas que realizan actividades de impacto sobre la salud o sus factores determinantes

h) La Sociedad Civil; y

i) La Población en general.

Es importante precisar, que el Ministerio de Economía y Finanzas utiliza el término Sector Salud para denominar al segmento del Presupuesto de la República que corresponde al Ministerio de Salud y sus órganos desconcentrados, de aplicación en su ámbito y no a la Rectoría del Sector Salud.

59) SERVICIO DE SALUD. -

Se reconocen dos acepciones:

1. Unidad asistencial de la estructura organizacional, del segundo o tercer nivel, de un establecimiento de salud. En el servicio confluyen recursos humanos, infraestructura, equipamiento, procesos, para brindar atenciones ambulatorias, de hospitalización o de emergencia, según corresponda. Así tenemos por ejemplo servicio de pediatría, servicio de medicina, servicio de cirugía, servicio de oftalmología, etc.
2. Tipo de producto que ofrece un establecimiento de salud, que se caracteriza por ser intangible, se produce y se consume en simultáneo, no se puede almacenar, y es por lo general personalizado. Se pueden ofrecer en actividades intramurales, extramurales, oferta virtual y oferta móvil. Por ejemplo, son servicios las consultas médicas, las atenciones de emergencia, las atenciones preventivas, las cirugías, etc.

   El conjunto de servicios que ofrece un establecimiento de salud constituye la *cartera de servicios*.

60) SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO. -

Son las IPRESS que funcionan independientemente o dentro de un establecimiento con internamiento o sin internamiento, según corresponda, que brindan servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad coadyuvar en el diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos.

61) SISTEMA DE SALUD. -

Desde la perspectiva doctrinaria en Salud Pública, el Sistema de Salud es el conjunto de instituciones u organizaciones vinculados directamente con la producción de todo tipo de servicios de salud, que contribuyen a la mejora de la salud y calidad de vida de la población y está conformado por:

a) Autoridad Nacional de Salud - MINSA como ente rector, y la Autoridad Regional de Salud.

b) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS: Públicas, privadas y mixtas, y sus respectivas instancias de gestión (Unidades de Gestión de IPRESS - UGIPRESS: Públicas, privadas y mixtas)

MINISTERIO DE SALUD DG N. HUAMANI

c) Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS: Públicas, privadas y mixtas

d) Usuarios de los servicios de salud

Desde el marco legal vigente, de acuerdo al D.L. 1504, el Sistema Nacional de Salud (SNS) asegura el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de salud para garantizar la salud individual y colectiva a nivel nacional. Se encuentra bajo la conducción del Ministerio de Salud como rector a nivel nacional en materia de salud. Además, está integrado por el ente rector, las instancias de coordinación interinstitucional y los órganos de los distintos niveles de gobierno, así como las entidades que los integran.

1. El Ministerio de Salud, ente rector del Sistema Nacional de Salud.
2. Instancias de Coordinación Interinstitucional:
   a) Consejo Nacional de Salud.
   b) Consejos Regionales de Salud.
   c) Consejos Provinciales de Salud.
   d) Comités Distritales de Salud.
3. Entidades a nivel nacional:
   - El Ministerio de Salud y sus organismos públicos adscritos, en ejercicio de sus competencias y atribuciones
   - El Seguro Social de Salud - EsSalud, la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, las sanidades de las Fuerza Armada, la dirección de salud del Instituto Nacional Penitenciario.
   - Los ministerios, organismos públicos, programas y proyectos del Poder Ejecutivo vinculados a implementación de las políticas de salud.
4. A nivel Regional:
   - Los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus veces, así como las demás instancias bajo su ámbito, en ejercicio de sus competencias y funciones en materia de salud, vinculados a las políticas de salud.
5. A nivel Local:
   - Las municipalidades provinciales y distritales e instancias bajo su ámbito, en ejercicio de sus competencias y funciones en materia de salud.
6. Otros:
   - Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas y privadas
   - Las Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas y privadas
   - Las demás instituciones públicas, privadas y público-privadas, vinculados a las políticas de salud.



N. HUAMANÍ

62) SISTEMA DE SALUD, FRAGMENTACIÓN DEL.-

Es la situación del Sistema de Salud en la cual cada subsistema al interior no tiene el suficiente nivel de coordinación, coherencia y sinergia en su propia red de servicios, de manera que no facilita el acceso, integralidad, oportunidad, continuidad de la atención de salud.

La fragmentación puede estar presente en cada subsistema, las redes, los establecimientos de salud, los propios servicios de salud, generando exclusión en la atención, ineficiencia, una inadecuada distribución y mal gasto de recursos.

63) SISTEMA DE SALUD, SEGMENTACIÓN DEL.-

Es la situación del Sistema de Salud donde coexisten subsistemas con sus propias reglas de organización, financiamiento, afiliación, provisión de servicio, mecanismos de acceso; cada uno de ellos "especializado" en diferentes estratos de la población de acuerdo a su inserción laboral, nivel de ingreso, capacidad de pago, posición económica y condición social.

En esta situación, cuando los subsistemas no establecen mecanismos de coordinación y articulación entre ellos, se agrava y profundiza la inequidad en el acceso de salud entre los diferentes grupos poblacionales, ya que hay personas que pueden acceder a más de un prestador, y otros que apenas acceden a alguno de ellos, o a ninguno.

64) SUPERVISIÓN. –

Es uno de los procesos de la función de control gerencial destinado a verificar el desempeño de las personas dentro de los procesos productivos en los que habitualmente se desenvuelve, en el marco de la política de salud vigente. La supervisión desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje mutuo, entre supervisor(es) y supervisado(s).

65) TELEAPOYO AL DIAGNÓSTICO. -

Es el servicio de apoyo al diagnóstico a distancia mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC, en el proceso de atención al paciente; incluye diagnóstico por imágenes, patología clínica, anatomía patológica, entre otros.

66) TELECAPACITACIÓN. -

Es el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso de las TIC, realizado por personal con las competencias necesarias, orientado a ampliar los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes del personal de la salud.

67) TELECONSULTA. -

Es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de la salud, en el marco de sus competencias, y una persona usuaria mediante el uso de las TIC, con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.

68) TELECONSULTA DE EMERGENCIA. -

Es una teleconsulta o teleinterconsulta prioritaria en casos en que el paciente se encuentre en situación de urgencia o emergencia.

69) TELECONSULTANTE. -

Persona usuaria o personal de la salud que labora en una IPRESS consultante, quien solicita servicios de Telemedicina a uno o más teleconsultores de una IPRESS consultora.

70) TELECONSULTOR. -

Médico especialista, médico cirujano, u otro profesional de la salud, que labora en una IPRESS consultora y brinda servicios de Telemedicina a uno o más teleconsultantes.

71) TELEGESTIÓN. -

Aplicación de los principios, conocimientos y/o métodos de la gestión de salud, mediante el uso de las TIC, en la planificación, organización, dirección y control de los servicios de salud.

72) TELEMEDICINA. -

Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, recuperación (incluido diagnóstico, tratamiento, y cuidados paliativos) y rehabilitación, prestados por personal de la salud que utiliza las TIC, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población.

73) TELESALUD. -

Servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación-TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población. Este servicio se efectúa considerando los siguientes ejes de desarrollo de la telesalud: la prestación de los servicios de salud, la gestión de los servicios de salud; la información, educación y comunicación con pertinencia cultural y lingüística; y el fortalecimiento de capacidades al personal de la salud, entre otros.

74) USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD O PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD. -

Es la persona que requiere y hace uso de los servicios de salud intramurales y extramurales de una IPRESS. No implica necesariamente que esté enfermo. Podría ser que use servicios orientados a la prevención de enfermedades, o a la promoción de la salud o de estilos de vida saludables, o algún servicio de tipo administrativo.

75) USUARIO DE TELESALUD. -

Persona beneficiaria directa de los servicios de Telesalud.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1. La Secretaría General del Ministerio de Salud es responsable de la difusión del presente Documento Técnico a los diversos órganos y unidades orgánicas, órganos desconcentrados, organismos públicos adscritos y programas; así como de su aplicación, en lo que corresponda.

7.2. Las direcciones y oficinas generales, de los diversos órganos y unidades orgánicas, órganos desconcentrados, organismos públicos adscritos y programas; y sus respectivos equipos técnicos, son responsables de tomar

como referencia obligatoria las definiciones y conceptos contenidos en el presente Documento Técnico, en los procesos de elaboración de los proyectos de normas legales, reglamentarias y de documentos normativos del Ministerio de Salud.

7.3. Los despachos Viceministeriales de Salud Pública y de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, así como la Secretaría General, son responsables de supervisar su aplicación y cumplimiento en los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Salud, bajo su autoridad.



N. HUAMANÍ

ANEXO

ÍNDICE ALFABÉTICO DE DEFINICIONES Y CONCEPTOS INCLUIDOS

	DEFINICIÓN O TÉRMINO	DENOMINACIÓN USUAL
1	ACTO DE SALUD.-	
2	ACTO MÉDICO	
3	ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD	
4	ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD	
5	ASISTENCIA TÉCNICA. –	
6	ATENCIONES DE SALUD	
7	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD.-	
8	ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	
9	CAPACIDAD DE OFERTA DE LA IPRESS	
10	CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA IPRESS	
11	CARPETA FAMILIAR	
12	CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD	
13	CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y SANITARIOS (CPMS)	
14	CICLO DE VIDA	
15	CLIENTE.-	
16	COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD	
17	COMPLEMENTARIEDAD DE SERVICIOS DE SALUD	
18	CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	
19	CUIDADO DE LA SALUD	
20	CUIDADOS INTEGRALES DE LA SALUD	
21	CUIDADOS INTEGRALES DE LA SALUD, MODELO DE	MODELO DE CUIDADOS INTEGRALES DE LA SALUD
22	CUIDADOS PALIATIVOS	
23	CURSO DE VIDA, ENFOQUE DE	ENFOQUE DE CURSO DE VIDA
24	DATOS PERSONALES	
25	DATOS PERSONALES RELACIONADOS CON LA SALUD	
26	DATOS SENSIBLES.	
27	DERECHO A LA SALUD	
28	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD	
29	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, ABORDAJE DE LOS	ABORDAJE DE LAS DSS
30	ENFERMO.-	
31	ENFOQUE.	
32	EQUIDAD EN SALUD	
33	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. –	
34	ETAPAS DE VIDA	
35	EVALUACIÓN. –	
36	FISCALIZACIÓN. –	
37	GESTIÓN SANITARIA	
38	GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD	
39	HIGIENE DE ALIMENTOS	
40	IAFAS Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud	
41	IGUALDAD EN SALUD	
42	INEQUIDAD EN SALUD	
43	INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	
44	INTERCAMBIO PRESTACIONAL	
45	INTERVENCIONES SANITARIAS.-	
	a. Prevención de Enfermedades	
	b. Promoción de la Salud	
	c. Recuperación de la Salud	
	d. Rehabilitación de la Salud	
46	IPRESS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	
47	IPRESS Consultante	
48	IPRESS Consultora	
49	MONITOREO. –	
50	PACIENTE.-	

MINISTERIO DE SALUD
DG
N. HUAMANÍ

51	PRESTACIONES DE SALUD	
52	PRINCIPIO.	
53	PROMOCIÓN DE LA SALUD	
54	RECTORÍA EN SALUD	
55	SALUD INTERCULTURAL	
56	SALUD, INTERCULTURALIDAD EN	INTERCULTURALIDAD EN SALUD
57	SALUD PÚBLICA	
58	SECTOR SALUD	
59	SERVICIO DE SALUD.-	
60	SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO.-	
61	SISTEMA DE SALUD O SISTEMA NACIONAL DE SALUD	
62	SISTEMA DE SALUD, FRAGMENTACIÓN DEL	FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
63	SISTEMA DE SALUD, SEGMENTACIÓN DEL	SEGMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
64	SUPERVISIÓN. –	
65	TELEAPOYO AL DIAGNÓSTICO	
66	TELECAPACITACIÓN	
67	TELECONSULTA	
68	TELECONSULTA DE EMERGENCIA	
69	TELECONSULTANTE	
70	TELECONSULTOR	
71	TELEGESTIÓN	
72	TELEMEDICINA	
73	TELESALUD.	
74	USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.-	
75	USUARIO DE TELESALUD	



N. HUAMANÍ